CAIRO UNIVERSITY · FACULTY OF NURSING · COMMUNITY HEALTH NURSING

Reproductive Health & *Family Planning*

Concept of Reproductive Health, ICPD Definition, Targeted Categories, Reproductive Health Services Package, Seven Key Reproductive Health Messages, Unmet Needs, Population Growth Determinants in Egypt, Maternal Health, Financial Resources, Human Rights (Article 8), and Contraceptive Options/Methods.

2nd Lecture · **Societal Issues (2026–2027)** · *Cairo University*

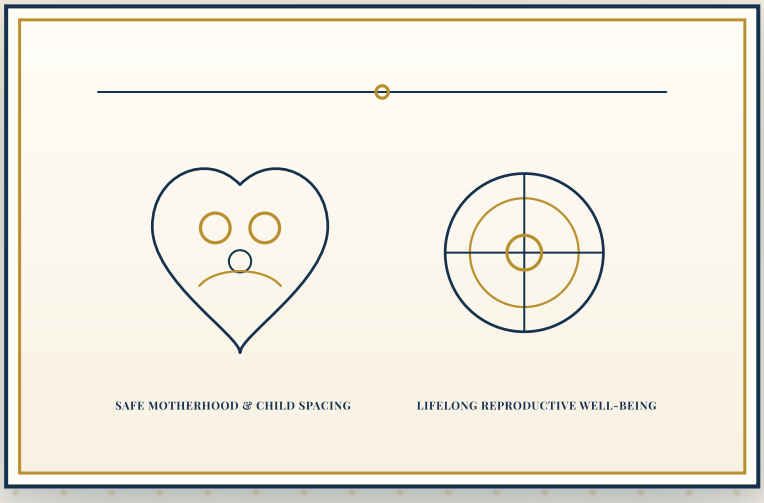


PLATE I — *Maternal, child, and family well-being through pregnancy spacing (left) and the lifelong approach to reproductive health across all life stages (right).*

Duas Before Studying

ابدأ مذاكرتك بهذه الأدعية المباركة لتيسير الفهم والحفظ والعلم النافع:

دعاء الفهم

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فَهْمَ النَّبِيِّينَ، وَحِفْظَ الْمُرْسَلِينَ، وَالْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ

دعاء قبل المذاكرة

اللَّهُمَّ افْتَحْ عَلَيَّ فُتُوحَ الْعَارِفِينَ بِحِكْمَتِكَ، وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، وَاشْرَحْ لِي صَدْرِي بِمَعْرِفَتِكَ

دعاء العلم النافع

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا، وَرِزْقًا طَيِّبًا، وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا

دعاء سيدنا موسى عليه السلام

رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي، وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي

نية المذاكرة

نَوَيْتُ بِمُذَاكَرَتِي هَذِهِ خِدْمَةَ مَرْضَى الْمُسْلِمِينَ وَنَفْعَ أُمَّةِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ ﷺ

دعاء تيسير العلم

اللَّهُمَّ لَا سَهْلَ إِلَّا مَا جَعَلْتَهُ سَهْلًا، وَأَنْتَ تَجْعَلُ الْحَزْنَ إِذَا شِئْتَ سَهْلًا

إرشاد للمذاكرة: يغطي هذا الملخص المحاضرة الثانية في القضايا المجتمعية — **الصحة الإنجابية وأساسيات تنظيم الأسرة (Reproductive Health and the Fundamentals of Family Planning)** بالكامل طبقًا لنص المحاضرة الرسمي حرفيًا دون أي إضافات خارجية.

1. Introduction & Concept of Reproductive Health

1. Introduction

— **Addressing Population Growth & Mortality:** Reproductive health and family planning programmes are essential to **addressing population growth**. They also contribute to **reducing maternal and child mortality rates**.

— **National & Global Strategies:** Reproductive health and family planning are **national and global strategies** for **reducing poverty** and **improving the living standards of families**. They aim to **improve the quality of life for citizens**.

— **Comprehensive Dimensions & Services:** Reproductive health and family planning programmes cover various **family, social, health, and cultural dimensions**. They also work to provide **vaccinations and primary care services**, as well as **follow-up medical examinations before and after marriage**, and take what is necessary in the context of **improving population characteristics**.

مقدمة حول برامج الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة:

- تُعد برامج الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة ضرورية **لمواجهة النمو السكاني**، كما تساهم في **خفض معدلات وفيات الأمهات والأطفال**.
- تُمثل استراتيجيات وطنية وعالمية **للحد من الفقر وتحسين مستويات معيشة الأسر**، وتهدف إلى **تحسين جودة حياة المواطنين**.
- تغطي أبعادًا **أسرية واجتماعية وصحية وثقافية** متنوعة، وتعمل على توفير **التطعيمات وخدمات الرعاية الأولية**، و**الفحوصات الطبية الدورية قبل وبعد الزواج**، واتخاذ ما يلزم في إطار **تحسين الخصائص السكانية**.

2. Concept & Definition of Reproductive Health

— **Core Concept: Reproductive health** is the **ability of people to enjoy a satisfying and safe sexual life, to be able to reproduce and have the freedom to choose when and how to do so**.

— **Awareness & Education:**

- It includes **men and women being aware** of **safe, effective, affordable, and acceptable family planning methods**.
- It includes **implementing education programmes** to emphasise that having a safe pregnancy and childbirth provides couples with the best chance of having a healthy child.

— **Scope Across Life Stages:**

- Includes **personal health habits, physical and mental safety, and sexual activity**. It is an essential part of **public health** that reflects the health level of men and women of childbearing age.
- Cares about the **prenatal stage** and **adolescent health**, and deals with the **post-childbearing stage** for women.
- Should be considered a **lifelong approach** because it affects both **men and women from childhood to old age** (*Preconception → Infancy and early years [0 to 5] → Childhood and adolescence [5 to 24] → Working age and adults [16 to 64] → Older people*). Reproductive health at any age profoundly impacts an individual's health later in life.

— **Shared Responsibility:**

- To achieve a better level of reproductive health, it is necessary to **involve men and women in the family's reproductive decisions**. These concepts should be provided to both young men and women **at an early age**.

- Reproductive health is *no longer the concern of married women of childbearing age only*. It is **everyone's responsibility at all stages of life**.

> **ICPD Official Definition:** Reproductive health has been defined in the programme of action issued by the **International Conference on Population and Development (ICPD)** as the **individual's physical, mental, and social well-being in all matters related to the reproductive system, its functions, and processes, and not merely the absence of disease or disability**.

مفهوم وتعريف الصحة الإنجابية (Reproductive Health):
- **المفهوم الأساسي:** قدرة الأفراد على التمتع بحياة جنسية مُرضية وآمنة، والقدرة على الإنجاب، وحرية اختيار متى وكيف يفعلون ذلك، مع وعي الرجال والنساء بوسائل تنظيم الأسرة الآمنة والفعالة والميسورة التكلفة والمقبولة، وتنفيذ برامج تثقيفية للتأكيد على أن الحمل والولادة الآمنين يمنحان الزوجين أفضل فرصة لإنجاب طفل سليم.
- **الشمول ومدى الحياة (Lifelong Approach):** تشمل العادات الصحية الشخصية والسلامة الجسدية والنفسية، وتهتم بمرحلة ما قبل الولادة وصحة المراهقين ومرحلة ما بعد سن الإنجاب للمرأة، فهي منهج يمتد مدى الحياة من الطفولة إلى الشيخوخة، وليست قاصرة على النساء المتزوجات في سن الإنجاب فقط، بل هي مسؤولية الجميع في كل مراحل العمر بمشاركة الرجل والمرأة معًا.
- **تعريف المؤتمر الدولي للسكان والتنمية (ICPD):** هي **حالة المعافاة البدنية والنفسية والاجتماعية الكاملة للفرد في جميع الأمور المتعلقة بالجهاز التناسلي ووظائفه وعملياته، وليست مجرد الخلو من المرض أو العجز.**

2. Targeted Categories, Reproductive Health Services & Package

1. The Categories Targeted by Reproductive Health Services (4 Categories)

— **1. Men and women of childbearing age:** to improve their health status.

— **2. Adolescents and youth:** to avoid harmful behaviours.

— **3. Women after childbearing age:** for the prevention of reproductive system diseases.

— **4. Postnatal children:** to maintain, protect, and promote their health.

الفئات المستهدفة بخدمات الصحة الإنجابية (4 فئات):
- **1. الرجال والنساء في سن الإنجاب:** لتحسين حالتهم الصحية.
- **2. المراهقون والشباب:** لتجنب السلوكيات الضارة.
- **3. السيدات بعد سن الإنجاب:** للوقاية من أمراض الجهاز التناسلي.
- **4. الأطفال بعد الولادة (Postnatal children):** للحفاظ على صحتهم وحمايتها وتعزيزها.

2. Reproductive Health Services

— Ensuring the right of men and women to know **safe, effective, affordable, and acceptable family planning methods**.

— Providing **high-quality family planning services**, including **infertility treatment services**.

— The right to access **appropriate healthcare services** that enable women to safely go through the **pregnancy and childbirth period**.

— Creating better opportunities for couples to have a **healthy child**.

— **Eliminating unsafe abortions**.

— **Combating sexually transmitted diseases**.

— **Promoting sexual health**.

— **Additional Services: Regular check-ups for children, periodic school examinations, and premarital examinations** are also part of reproductive health services.

3. Reproductive Health Services Package

FOR CHILDREN AND ADOLESCENTS	FOR WOMEN	FOR COUPLES (MEN AND WOMEN)
Child Health	Safe Motherhood	Comprehensive Family Planning Services
Issues Related to Sexual and Reproductive Health	Postpartum and Post-abortion Care	Treatment of Reproductive Health Issues (Infertility and Diseases)
—	Early Detection of Tumors	Prevention and Treatment of Sexually Transmitted Infections

خدمات الصحة الإنجابية وحزمة الخدمات (Reproductive Health Services Package):
- **الخدمات المقدمة:** ضمان حق الرجال والنساء في معرفة وسائل تنظيم الأسرة الآمنة والفعالة، تقديم خدمات تنظيم أسرة عالية الجودة شاملة **علاج العقم (Infertility treatment)**، رعاية الحمل والولادة الآمنة، القضاء على الإجهاض غير الآمن، مكافحة الأمراض المنقولة جنسيًا، تعزيز الصحة الجنسية، بالإضافة إلى **الفحوصات الدورية**

للأطفال، والفحوصات المدرسية الدورية، وفحوصات ما قبل الزواج.
• **حزمة خدمات الصحة الإنجابية:**
— **للأطفال والمراهقين:** صحة الطفل | القضايا المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية.
— **للسيدات:** الأمومة الآمنة (Safe Motherhood) | رعاية ما بعد الولادة وما بعد الإجهاض | الكشف المبكر عن الأورام.
— **للزوجين (الرجال والنساء):** خدمات تنظيم الأسرة الشاملة | علاج مشاكل الصحة الإنجابية (العقم والأمراض) | الوقاية والعلاج من العدوى المنقولة جنسيًا.

3. Key Messages About Reproductive Health (Part I: Messages 1–4)

The 7 Key Messages About Reproductive Health: (1) Pre-marital care, (2) Delaying the birth of the first child, (3) The role of men in family planning and reproductive health, (4) Pregnancy spacing, (5) Prevention of child marriage, (6) The importance of female education, (7) Limiting marriages between close relatives to avoid genetic diseases.

1. Pre-Marital Care & 2. Delaying the Birth of the First Child

1. PRE-MARITAL CARE

— Aims to provide **health education** for those intending to marry and **medical, psychological, and social interventions** to prepare individuals for marriage.

— Evaluates potential risks that couples may face, discusses appropriate family planning methods, and provides **counselling to prevent the transmission of infections between spouses**.

— Assists couples in planning for a **healthy pregnancy and childbirth** while raising awareness of the importance of **pregnancy spacing**.

— **Medical history** and necessary **medical examinations and tests** are conducted.

2. DELAYING THE BIRTH OF THE FIRST CHILD

— Allows couples to **strengthen their relationship** and **enjoy married life without any responsibilities**, enhancing stability.

— Helps couples **adapt to the new life** and the successive changes in the responsibilities of **marriage, home, children, and perhaps work** if the woman is employed.

الرسالتان الأولى والثانية (رعاية ما قبل الزواج وتأجيل إنجاب الطفل الأول):
• **1. رعاية ما قبل الزواج (Pre-marital care):** تهدف لتقديم التثقيف الصحي للمقبلين على الزواج والتدخلات الطبية والنفسية والاجتماعية لإعدادهم للزواج، وتقييم المخاطر المحتملة، ومناقشة وسائل تنظيم الأسرة المناسبة، وتقديم المشورة **لمنع انتقال العدوى بين الزوجين**، والتخطيط لحمل وولادة آمنين مع التوعية بالمباعدة بين الحمول وإجراء التاريخ الطبي والفحوصات والتحاليل اللازمة.
• **2. تأجيل إنجاب الطفل الأول:** يتيح للزوجين تقوية علاقتهما والاستمتاع بالحياة الزوجية دون أعباء مما يعزز الاستقرار، ويساعدهما على التكيف مع الحياة الجديدة والتغيرات المتتالية في مسؤوليات الزواج والمنزل والأطفال والعمل (إذا كانت المرأة عاملة).

3. The Role of Men in Family Planning and Reproductive Health (6 Roles)

— **1.** Adopt the concept of a **small family**.

— **2.** Participate in **making decisions about pregnancy and childbirth** with the wife.

— **3. Encourage the wife** to decide on family planning.

— **4.** Care about **following up on the health of the mother and her family**.

— **5. Change attitudes** towards family planning and **change reproductive behaviour**.

— **6. Awareness of the importance of the population problem** and its impact on the economic situation of the family and society.

4. Pregnancy Spacing

— **Maternal & Child Health Protection:** Pregnancy spacing helps to **protect the lives of mothers and their babies**, **reduce the incidence of abortion and unintended pregnancy**, promote the health of mothers and babies, improve the health of **children and their nutrition and growth**, and help **mothers to recover physically and emotionally** before getting pregnant again and facing the requirements of another pregnancy and what follows from childbirth, breastfeeding and caring for the new-born.

— **Family & Educational Impact:** It allows parents to **devote more time to caring for their child**, which **improves children's school performance** and provides space for couples to **spend better time together** and thus **maintain marital relationships and affection** (*spacing between pregnancies of 2 years or more improves the outcome of pregnancy*).

الرسالتان الثالثة والرابعة (دور الرجل والمباعدة بين الحمول):
• **3. دور الرجل في تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية (6 أدوار):** (1) تبني مفهوم الأسرة الصغيرة، (2) المشاركة في اتخاذ قرارات الحمل والإنجاب مع الزوجة، (3) تشجيع الزوجة على قرار تنظيم الأسرة، (4) الاهتمام بمتابعة صحة الأم والأسرة، (5) تغيير الاتجاهات نحو تنظيم الأسرة وتغيير السلوك الإنجابي، (6) الوعي بأهمية المشكلة السكانية وتأثيرها على الوضع الاقتصادي للأسرة والمجتمع.
• **4. المباعدة بين الحمول (Pregnancy spacing):** تحمي حياة الأمهات وأطفالهن، وتقلل الإجهاض والحمل غير المقصود، وتحسن تغذية ونمو الأطفال، وتساعد الأم على **التعافي جسديًا ونفسيًا** قبل الحمل التالي، وتتيح للوالدين تكريس وقت أكبر لرعاية الطفل مما **يحسن الأداء الدراسي للأطفال** ويحافظ على المودة والعلاقة الزوجية.

4. Key Messages About Reproductive Health (Part II: Messages 5–7)

5. Prevention of Child Marriage

— **Definition: Child marriage** is a union in which one or both parties are **under 18 years old** or have not reached the age of majority as specified by the state.

— **Social Consequences:** Early marriage yields various social consequences, including **premature divorce** stemming from the spouses' unpreparedness to establish a successful family due to their youth and limited understanding of family dynamics.

- **Some of the social impacts of early marriage include:**

1. **Spread of domestic violence**.
2. **Spread of poverty**.
3. **The decline in the level of education**.

— **Negative Health Outcomes:**

- Leads to **anaemia** and **high blood pressure in mothers**.
- Young mothers, aged between **10 and 19**, face a higher likelihood of **pregnancy-related complications**, **postpartum uterine infections**, and **reproductive tract infections**.
- Teenage mothers are **twice as likely to experience postpartum depression** compared to older mothers. They may exhibit **mood swings, anxiety, sadness, difficulty concentrating, eating, and sleeping for one to two weeks**.

5. منع زواج الأطفال (Prevention of Child Marriage):
• **التعريف:** زواج يكون فيه أحد الطرفين أو كلاهما **أقل من 18 عامًا** أو لم يبلغ سن الرشد المحدد قانونًا.
• **الآثار الاجتماعية:** الطلاق المبكر (Premature divorce) نتيجة عدم نضج الزوجين وعدم استعدادهما لتكوين أسرة ناجحة، وتشمل الآثار الاجتماعية: (1) **انتشار العنف الأسري**، (2) **انتشار الفقر**، (3) **انخفاض مستوى التعليم**.
• **النتائج الصحية السلبية:** إصابة الأمهات **بالأنيميا وارتفاع ضغط الدم**، وتواجه الأمهات الصغيرات (بعمر **10 إلى 19 سنة**) احتمالية أعلى لمضاعفات الحمل، وعدوى الرحم بعد الولادة، وعدوى الجهاز التناسلي، كما تكون الأمهات المراهقات **أكثر عرضة بمرتين (Twice as likely) للإصابة باكتئاب ما بعد الولادة** مقارنة بالأمهات الأكبر سنًا (تقلبات مزاجية، قلق، حزن، وصعوبة في التركيز والأكل والنوم لمدة **أسبوع إلى أسبوعين**).

6. The Importance of Female Education & 7. Limiting Consanguineous Marriages

6. IMPORTANCE OF FEMALE EDUCATION

— **Women's education** reflects on their **children's behaviour** when they are educated and empowered in society, allowing them **freedom in managing their families**.

— Educating girls completely **changes a woman's perception and attitudes**, transferring these changes to her **children, family, and the surrounding community**, contributing to the overall improvement of society.

7. LIMITING MARRIAGES BETWEEN CLOSE RELATIVES

— **Genetic diseases** are a heavy burden on all societies.

— Many studies have shown the link between **consanguineous marriages** and the **death of fetuses** and **congenital defects in new-borns**.

الرسالتان السادسة والسابعة (أهمية تعليم الإناث والحد من زواج الأقارب):
• **6. أهمية تعليم الإناث:** ينعكس تعليم المرأة على سلوك أطفالها عندما تكون متعلمة ومُمكّنة في المجتمع، مما يمنحها الحرية في إدارة أسرتها، فتعليم الفتيات يغير إدراك المرأة واتجاهاتها بالكامل وينقل هذا التغيير الإيجابي لأطفالها وأسرتها والمجتمع المحيط.
• **7. الحد من زواج الأقارب لتجنب الأمراض الوراثية:** تمثل الأمراض الوراثية عبئًا ثقيلًا على المجتمعات، وقد أثبتت العديد من الدراسات العلاقة الوثيقة بين **زواج الأقارب (Consanguineous marriages)** ووفاة الأجنة والتشوهات الخلقية في المواليد.

5. Fundamentals of Family Planning, Unmet Needs & Population Growth

1. Definition & Importance of Family Planning (FP)

— **Definition of Family Planning:** It is a **conscious, organized, and free effort** that couples make to **regulate fertility or control it**, either by **delaying, spacing, or limiting the number of births**. It is carried out through a regular work program to provide family planning information and services to **reduce fertility and improve public health**.

— **Importance of Family Planning (4 Points):**

- **1.** The ability to **determine the number of children and space pregnancies freely and responsibly**.

- **2. Protection from unintended pregnancy**.
- **3.** The possibility for women to have **better opportunities to continue their education or work**.
- **4.** Family planning **saves mothers' lives** by: (a) **Reducing the number of births**, (b) **Spacing pregnancies**, and (c) **Reducing pregnancies at a very young age or in the late stages of childbearing**.

تعريف وأهمية تنظيم الأسرة (Family Planning):
• **التعريف:** هو **مجهود واعٍ ومنظم وحر** يقوم به الزوجان لتنظيم الخصوبة أو التحكم فيها، سواء عن طريق **تأجيل أو مباعدة أو تحديد عدد المواليد**، من خلال برنامج عمل منتظم لتوفير معلومات وخدمات تنظيم الأسرة لخفض الخصوبة وتحسين الصحة العامة.
• **الأهمية:** (1) القدرة على تحديد عدد الأطفال والمباعدة بين الحمول بحرية ومسؤولية، (2) الحماية من الحمل غيرِ المقصود، (3) إتاحة فرص أفضل للمرأة لاستكمال تعليمها أو عملها، (4) **إنقاذ حياة الأمهات** عن طريق: تقليل عدد الولادات، المباعدة بين الحمول، وتقليل الحمل في سن مبكرة جدًا أو في المراحل المتأخرة من سن الإنجاب.

2. Unmet Family Planning Needs for Women & Their 4 Reasons

— **Concept & Magnitude: More than 100 million women** in developing countries want to avoid pregnancy but do not use any family planning methods for various reasons. This situation is described as **unmet family planning needs**, where women wish to avoid pregnancy but do not use family planning methods for various reasons.

— **Reasons for Unmet Family Planning Needs (4 Reasons):**

- **1.** Concerns about the **side effects** of contraceptive methods.
- **2.** Lack of **information** about family planning methods or where to obtain them.
- **3.** Difficulty **accessing** modern contraceptives due to distant service locations, high costs, or irregular visits to mobile clinics.
- **4. Opposition** from spouses, families, and communities.

3. Family Planning as a Key Determinant of Population Growth in Egypt & Main Goal

4 DIRECT FACTORS OF FERTILITY RATE CHANGES IN EGYPT	IMPACT & MAIN GOAL OF FAMILY PLANNING
1. **Family planning: 64%** 2. **Breastfeeding: 14%** 3. **Intentional abortion: 12%** 4. **Age at marriage: 10%**	— Prevents approx. **4 million unintended pregnancies** and around **1.6 million unsafe abortions** annually in Egypt (**2019 data**). — Arabic word "planning" is derived from **"nazama"** (to arrange, manage, and coordinate). — **Main Goal:** To **ensure that couples have the resources (social, material, environmental, and time) they need to fulfil their goal of having a child**.

الحاجة غير الملبّاة لتنظيم الأسرة، محددات النمو السكاني في مصر، والهدف الرئيسي:
• **الحاجة غير الملبّاة (Unmet FP Needs): أكثر من 100 مليون امرأة** في الدول النامية يرغبن في تجنب الحمل ولكنهن لا يستخدمن أي وسيلة لتنظيم الأسرة، وأسبابها الأربعة: (1) الخوف من الآثار الجانبية للوسائل، (2) نقص المعلومات عن الوسائل أو أماكن الحصول عليها، (3) صعوبة الوصول للوسائل الحديثة لبُعد الأماكن أو ارتفاع التكلفة أو عدم انتظام العيادات المتنقلة، (4) معارضة الزوج أو الأسرة أو المجتمع.
• **العوامل الأربعة المباشرة المؤثرة في معدلات الخصوبة بمصر: تنظيم الأسرة (64%)، الرضاعة الطبيعية (14%)، الإجهاض المتعمد (12%)، والسن عند الزواج (10%)**؛ ويمثل تنظيم الأسرة أهم محدد للنمو السكاني في مصر حيث يمنع حوالي **4 ملايين حمل غير مقصود** وحوالي **1.6 مليون إجهاض غير آمن** سنويًا (وفق بيانات 2019).
• **الهدف الرئيسي لتنظيم الأسرة:** كلمة «تنظيم» مشتقة من الفعل «**نَظَمَ**» (رتّب وأدار ونسّق)، ويهدف تنظيم الأسرة إلى **ضمان امتلاك الزوجين للموارد الاجتماعية والمادية والبيئية والوقت اللازم لتحقيق هدفهم في إنجاب طفل.**

6. Family Planning: Maternal Health, Financial Resources & Human Rights

1. Family Planning and Maternal Health

— **WHO Definition of Maternal Health:** The World Health Organisation (WHO) defines **maternal health** as **women's safety during pregnancy, childbirth, and postpartum**.

— **Maternal Mortality & Recommended Waiting Intervals:**

- Approximately **99% of maternal deaths** in developing countries are due to **early or late pregnancy**. Adolescents and teenagers face the risk of complications and death due to pregnancy.
- Therefore, it is advisable to wait until the **age of eighteen (18 years)** before attempting pregnancy.
- For the health of both the mother and her child, it is recommended to wait **at least two years (2 years)** from the date of the last birth before attempting another pregnancy.
- In cases of **fetal loss or abortion**, it is health-wise recommended to wait **at least six months (6 months)**.

— **Risks of Advanced Maternal Age & Advantages of Spacing:**

- As a woman's age advances, the likelihood of having children with **autism** or **Down Syndrome** increases, and multiple births and late pregnancies raise the risk of **diabetes** and increase the rate of **cesarean sections**.
- **Pregnancy spacing advantages:** reducing infant and maternal mortality rates, as well as lowering rates of **stunting, obesity, anaemia, and autism**.

تنظيم الأسرة وصحة الأم (Family Planning and Maternal Health):
• **تعريف منظمة الصحة العالمية (WHO) لصحة الأم:** هي **سلامة المرأة أثناء الحمل والولادة وفترة ما بعد الولادة (النفاس)**.
• **الوفيات والفترات الزمنية الموصى بها:** حوالي **99% من وفيات الأمهات** في الدول النامية ترجع إلى الحمل المبكر أو المتأخر؛ لذا يُنصح بالانتظار حتى **سن 18 عامًا** قبل محاولة الحمل، والانتظار **سنتين على الأقل** من تاريخ آخر ولادة قبل محاولة حمل جديد، وفي حالة فقدان الجنين أو الإجهاض يُوصى بالانتظار **6 أشهر على الأقل**.
• **مخاطر تقدم عمر الأم وفوائد المباعدة:** مع تقدم عمر المرأة تزداد احتمالية إنجاب أطفال مصابين **بالتوحد (Autism) أو متلازمة داون**، كما تزيد الولادات المتعددة والحمل المتأخر من خطر **السكري والولادات القيصرية**. وتعمل المباعدة بين الحمول على خفض وفيات الأمهات والرضع وخفض معدلات **التقزم (Stunting) والسمنة والأنيميا والتوحد**.

2. Family Planning and Financial Resources

— **Cost-Effective Investment:** Family planning is among the most **cost-effective health interventions** for a country. The economic impact of population growth on human capital quality in Egypt makes family planning an economic investment with positive returns that affect current and future generations.

— **Government Service Savings:** Family planning helps avoid the costs of providing government services, especially **education, health, food support, housing, and social facilities**.

— **Global Impact on Mortality & SDGs:** Providing global sexual and reproductive health services will eliminate unmet contraceptive needs, leading to:

- A reduction of **640,000 neonatal deaths** worldwide.
- A decrease of **150,000 maternal deaths** globally.
- A decrease in the number of **children losing their mothers by 600,000**.
- Expenditures on population activities (family planning, sexual/reproductive health, data analysis, population policies) are crucial indicators of achieving the **Sustainable Development Goals (SDGs)**.

3. Family Planning and Human Rights

— Access to secure and voluntary family planning is recognized as a **human right** and is a key element of **gender equality, women's empowerment, and poverty reduction**.

Article 8 (Global Consensus): *"All couples and individuals have the basic right to decide freely and responsibly about the number of their children and pregnancy spacing, and to have the information and means to do so."*

تنظيم الأسرة والموارد المالية وحقوق الإنسان:
• **الموارد المالية:** يعد تنظيم الأسرة من أكثر التدخلات الصحية **فعالية من حيث التكلفة (Cost-effective)**، ويوفر تكاليف الخدمات الحكومية (التعليم، الصحة، دعم الغذاء، الإسكان، والمرافق الاجتماعية). وعالميًا، يؤدي القضاء على الحاجات غير الملبّاة إلى خفض **640,000 وفاة حديثي ولادة**، وخفض **150,000 وفاة أمهات**، وتقليل عدد الأطفال الذين يفقدون أمهاتهم بمقدار **600,000 طفل**، وهو مؤشر حاسم لتحقيق **أهداف التنمية المستدامة (SDGs)**.
• **حقوق الإنسان (المادة 8 — Article 8):** الوصول لتنظيم الأسرة الآمن والطوعي حق من حقوق الإنسان وعنصر أساسي للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والحد من الفقر، وتنص **المادة 8** على أن: «لجميع الأزواج والأفراد الحق الأساسي في أن يقرروا بحرية ومسؤولية عدد أطفالهم والمباعدة بين الحمول، وفي الحصول على المعلومات والوسائل اللازمة لذلك».

7. Benefits of Family Planning & Effect of Low FP Service Coverage

1. Benefits of Family Planning for Women, Children, Families & Communities

BENEFITS FOR WOMEN

— **Lower risk of maternal death**.
— **Lower risk of anemia**, poor pregnancy outcomes and complications, and complications related to miscarriage or unsafe abortion.
— **Improved educational and economic opportunities**.

BENEFITS FOR CHILDREN

— **Longer breastfeeding:**
· Provides nutrition
· Protects from childhood diseases
· Improves mother/child bonding

— **Reduces child illness and death**.

— **Allows more time and resources** for parents to meet the needs of each child.

BENEFITS FOR FAMILIES & COMMUNITIES

— Families can **devote more resources** to providing for each child.

— Reduced maternal and child illness **reduces economic strain** on family.

— Reduced maternal deaths **strengthen families and communities**.

— **Relieves economic, social, and environmental pressures**.

— **Enhances women's status** and promotes equality between men and women.

Benefits of Providing FP Services (3-Step Chain): 1. Allow women and couples to delay, space, and limit pregnancies → **2.** Helps achieve the healthiest outcomes for women and their children → **3.** Improves well-being of families and communities.

فوائد تنظيم الأسرة للمرأة والطفل والأسرة والمجتمع:
• **للمرأة:** خفض خطر وفاة الأم، خفض خطر الأنيميا ومضاعفات الحمل والإجهاض غير الآمن، وتحسين الفرص التعليمية والاقتصادية.
• **للطفل:** رضاعة طبيعية أطول (توفر التغذية، تحمي من أمراض الطفولة، وتحسن الترابط بين الأم والطفل)، تقليل مرض ووفاة الأطفال، وإتاحة وقت وموارد أكبر للوالدين لتلبية احتياجات كل طفل.
• **للأسرة والمجتمع:** تخصيص موارد أكثر لكل طفل، تقليل العبء الاقتصادي الناتج عن مرض الأم والطفل، تقوية الأسر والمجتمعات، تخفيف الضغوط الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتعزيز مكانة المرأة والمساواة بين الرجل والمرأة.

2. Effect of a Low FP Service Coverage (Causal Pathway)

STAGE	PATHWAY BRANCH A (MATERNAL HEALTH)	PATHWAY BRANCH B (DEMOGRAPHIC / SOCIAL)
Root Cause	**Low FP Service Coverage** → leads directly to → **High Rate of Unwanted Pregnancy**	
Intermediate Outcome	**Unsafe Abortion**	**↑ Family / Population Size**
Direct Consequences	— **Increase Maternal Morbidity** — **High MMR** (Maternal Mortality Ratio)	— **Poverty** — **Migration**
Final Outcome	**Ill Health and Social Wellbeing**	

أثر انخفاض التغطية بخدمات تنظيم الأسرة (Effect of Low FP Service Coverage):
• يؤدي **انخفاض التغطية بخدمات تنظيم الأسرة** إلى **ارتفاع معدل الحمل غير المرغوب فيه (High rate of unwanted pregnancy)**، والذي يتفرع إلى مسارين:
1. **إجهاض غير آمن (Unsafe abortion):** يؤدي إلى زيادةراضة الأمهات (Maternal morbidity) وارتفاع معدل وفيات الأمهات (High MMR).
2. **زيادة حجم الأسرة والسكان (↑ Family / Population size):** يؤدي إلى الفقر (Poverty) والهجرة (Migration).
• وينتهي المساران معًا بـ **اعتلال الصحة والرفاه الاجتماعي (Ill Health and Social Wellbeing)**.

8. Family Planning Methods, Effectiveness & Review Questions

1. Family Planning Options / Methods (5 Categories)

METHOD CATEGORY	EXAMPLES, DURATION & MECHANISM IN LECTURE
1. Short-Acting Hormonal Methods	— **Examples: Oral contraceptives**, **vaginal ring**, **skin patch**, and **Depo-Provera injection** (150 mg/mL). — **Why short-acting:** They must be remembered to use on a **daily, weekly, or monthly basis**.
2. Long-Acting Methods	— **Examples: Copper IUD**, **hormonal IUD**, and **subdermal implants**. — **Why long-acting:** They last for **three to 10 years** (depending on the type) or until the woman decides to have the device removed.
3. Sterilization (Permanent)	— A **permanent method** of birth control. — **Examples: Tubal ligation for women** (Fallopian tubes tied and cut) and **vasectomy for men** (Vas deferens tied and cut).
4. Fertility Awareness Methods	— Focus on **knowing the days of the month when pregnancy can occur**, often based on **basal body temperature** and **cervical mucus**.
5. Emergency Contraception	— Includes the **morning-after pill** (high-dose hormonal pills). — Can be taken **up to 72 hours AFTER intercourse**, but the sooner someone uses emergency contraception the more effective it is.

2. Effectiveness, Non-Contraceptive Benefits & Selection Factors

— **How Effective Are the Methods?** To be effective, any method must be used **consistently and correctly**. Methods requiring little effort from the user—such as **IUDs, subdermal implants, and sterilization** (placed by a healthcare provider)—achieve **high rates of protection and lower rates of pregnancy**.

— **Other Benefits Beyond Preventing Pregnancy:** (1) **Reducing the amount of blood during menstruation**, (2) **Reducing the risk of sexually transmitted infections**, or (3) **Reducing the risk of developing certain types of cancer**.

— **Factors Affecting the Best Method for a Woman:** May change throughout her life depending on **age, health history, number of children she wants or the right time to get pregnant**, and method differences (**effectiveness, side effects, cost, and whether they prevent STIs**).

وسائل تنظيم الأسرة، الفعالية، الفوائد الإضافية، وعوامل الاختيار:
• **الوسائل الخمس:** (1) **هرمونية قصيرة المفعول:** الأقراص الفموية، الحلقة المهبلية، لاصقة الجلد، وحقن ديبو-بروفيرا (تُستخدم يوميًا أو أسبوعيًا أو شهريًا). (2) **طويلة المفعول:** اللولب النحاسي، اللولب الهرموني، والكبسولات تحت الجلد (تستمر من **3 إلى 10 سنوات**). (3) **التعقيم (وسيلة دائمة):** ربط قناتي فالوب للسيدات (Tubal ligation) وقطع القناة الدافقة للرجال (Vasectomy). (4) **الوعي بالخصوبة:** معرفة أيام التبويض عبر حرارة الجسم الأساسية ومخاط عنق الرحم. (5) **منع الحمل الطارئ:** حبة الصباح التالي (جرعة هرمونية عالية تؤخذ خلال **72 ساعة بعد الجماع**، وكلما استخدمت مبكرًا كانت أكثر فعالية).
• **الفعالية والفوائد الأخرى:** تتطلب الاستخدام المنتظم والصحيح؛ وتتميز اللوالب والكبسولات والتعقيم بأعلى معدلات الحماية. ومن فوائدها الأخرى: تقليل كمية دم الحيض، تقليل خطر العدوى المنقولة جنسيًا، وتقليل خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان.

3. Official Lecture Question & Self-Evaluation MCQs

1 **[Official Slide Question] Combined oral contraceptives are one of the long-acting hormonal contraceptives. (True / False)**

- ○ a) True
- ○ **b) False (Oral contraceptives are short-acting hormonal methods; IUDs and subdermal implants are long-acting methods lasting 3–10 years) ✓**

الإجابة الرسمية: خطأ (False) — أقراص منع الحمل الفموية (Oral contraceptives) هي من الوسائل الهرمونية قصيرة المفعول (Short-acting) لأنها تُؤخذ يوميًا، بينما تشمل الوسائل طويلة المفعول اللولب النحاسي والهرموني والكبسولات تحت الجلد (3–10 سنوات).

2 **According to the lecture data on fertility rate changes in Egypt, which factor is the primary direct determinant (64%), and how many unintended pregnancies does it prevent annually?**

- ○ a) Breastfeeding (64%); prevents 1 million unintended pregnancies
- ○ **b) Family planning (64%); prevents approximately 4 million unintended pregnancies and 1.6 million unsafe abortions annually ✓**
- ○ c) Age at marriage (64%); prevents 500,000 unintended pregnancies
- ○ d) Intentional abortion (64%); prevents 2 million unintended pregnancies

الإجابة: b — يمثل تنظيم الأسرة 64% من العوامل المباشرة المؤثرة في معدلات الخصوبة في مصر (يليه الرضاعة الطبيعية 14%، الإجهاض المتعمد 12%، والسن عند الزواج 10%)، ويمنع حوالي 4 ملايين حمل غير مقصود و1.6 مليون إجهاض غير آمن سنويًا.

3 **What are the recommended minimum waiting intervals for pregnancy according to the lecture (minimum age, after last birth, and after fetal loss/abortion)?**

- ○ a) Age 15 years; 1 year after birth; 1 month after abortion
- ○ **b) Wait until age 18 years; at least 2 years after the last birth; at least 6 months after fetal loss or abortion ✓**
- ○ c) Wait until age 21 years; at least 5 years after birth; 2 years after abortion
- ○ d) Wait until age 16 years; 6 months after birth; 6 months after abortion

الإجابة: b — يُنصح بالانتظار حتى سن 18 عامًا قبل الحمل الأول، والانتظار سنتين على الأقل بعد آخر ولادة، و6 أشهر على الأقل بعد الإجهاض أو فقدان الجنين.

Closing

كفارة المجلس

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

دعاء بعد المذاكرة

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَوْدِعُكَ مَا عَلَّمْتَنِيهِ، فَارْدُدْهُ إِلَيَّ عِنْدَ حَاجَتِي إِلَيْهِ، وَلَا تَنْسَنِيهِ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ

🤍 **ختامًا:** نسأل الله أن يجعله **علمًا نافعًا**، وأن يوفقك في الامتحان ويكرمك بالنتيجة **التي ترضاها** يا رب العالمين. آمين 🌿